

DOENÇAS DA POLPA E DO PERIÁPICE

Guia de revisão para prova — Patologia Bucal (UNESC)

Baseado nos slides "Doenças da Polpa e Periapíce" (Profa. Ângela Catarina Maragno) e no gabarito da Atividade Discente 1 da disciplina de Patologia Bucal. Cobre as aulas de 10/08, 17/08 e 24/08.

COMO LER OS ESQUEMAS

Cada linha traz um esquema autoral no padrão "raio-X anotado" — o mesmo código visual usado em aula para descrever características radiográficas (radiolúcido × radiopaco, contorno bem × mal definido). Não são fotografias clínicas.



Laranja/vermelho na polpa = inflamação pulpar vital (mais escuro = mais intenso).



Cinza-escuro na polpa/canal = necrose pulpar (sem vitalidade).



Círculo escuro de contorno nítido no ápice = radiolúcido bem definido (granuloma/cisto).



Mancha escura irregular no ápice = radiolúcido mal definido, agudo (abscesso).



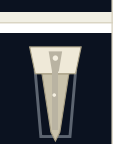
Área clara/densa = radiopaco (osteíte condensante, sequestro, Garré).

CATEGORIAS

■ Alterações Pulpares	5 entidades
■ Alterações Periapicais Agudas	2 entidades
■ Alterações Periapicais Crônicas	5 entidades
■ Complicações por Disseminação	3 entidades
■ Osteomielites e Condições Ósseas Correlatas	5 entidades

Perguntas-chave de anamnese (repita para cada caso clínico): dor provocada ou espontânea? o paciente sabe localizar o dente? há sensibilidade à percussão? há expressão radiográfica? há sintomatologia sistêmica (febre, mal-estar)? o paciente está debilitado sistemicamente (ex.: diabetes)? houve procedimento odontológico recente?

ALTERAÇÕES PULPARES

Esquema	Doença	Aparência clínica / achado-chave	Como diferenciar	Localização	Causa / etiologia	Tratamento
	Pulpite Reversível	Dor de curta duração ao frio, some rápido	Pulpite irreversível: na reversível a dor SOME ao retirar o estímulo; na irreversível a dor CONTINUA mesmo sem o estímulo.	Câmara pulpar do dente afetado, geralmente associada a cárie inicial, desgaste cervical ou restauração recente.	Cárie inicial / trauma leve / restauração	Remover causa + proteger polpa
	Pulpite Irreversível	Dor espontânea/pulsátil; doi ao calor, alivia no frio	Pulpite reversível: nesta a dor cessa ao remover o estímulo. Pólipo pulpar: forma crônica, geralmente indolor, com tecido de granulação visível.	Estágio inicial: dente bem localizado. Estágio avançado: dor difusa (inervação C amielínica dissemina o estímulo).	Cárie profunda / trauma não tratados	Endodontia ou exodontia
	Pulpite Crônica Hiperplásica (Pólipo Pulpar)	Massa avermelhada saindo do dente destruído	Hiperplasia gengival sobre a cavidade: tem CONTINUIDADE com a gengiva. O pólipo pulpar NÃO tem continuidade e tem coloração mais escura.	Molares decíduos e permanentes jovens, com câmaras pulpares amplas e grande exposição pulpar.	Exposição pulpar crônica em jovem (ápice aberto)	Pulpectomia/endodontia ou exodontia
	Necrose Pulpar	Sem resposta a nenhum teste de vitalidade	Calcificação/metamorfose cálcica: também altera o teste de vitalidade, mas SEM sintomas e com canal obliterado (não ha destruição tecidual).	Toda a polpa (câmara e canal) do dente acometido.	Pulpite irreversível não tratada / trauma	Endodontia ou exodontia
	Calcificações Pulpares (Denticulos / Cálculos)	Pontos radiopacos na polpa, assintomático	Metamorfose cálcica pos-trauma: cursa com escurecimento amarelado da coroa e obliteração quase total do canal - calcificação comum não altera a cor do dente.	Denticulos: câmara e canais, próximos as furcas de multirradiculares. Cálculos pulpares: porção coronária da polpa.	Irritação pulpar crônica / idade	Nenhum (observação)

ALTERAÇÕES PERIAPICAIS AGUDAS

Esque ma	Doença	Aparência clínica / achado-chave	Como diferenciar	Localização	Causa / etiologia	Tratamento
	Periodontite Apical Aguda (Pericementite)	Dor a percussão/oclusão, pode ser dente vital	Abscesso periapical agudo: tem SUPURAÇÃO (pus) e tende a evoluir com edema; a periodontite apical aguda é só inflamação do ligamento, sem coleção purulenta.	Ligamento periodontal apical.	Trauma oclusal / dente desvitalizado	Ajuste oclusal (vital) ou endo/exo (não vital)
	Abscesso Periapical Agudo	Dor intensa + extrusão + edema, pode ter febre	Abscesso periapical CRÔNICO: este é agudo, doloroso, com sinais sistêmicos; o crônico é silencioso, indolor e de longa duração.	Ápice de um dente desvitalizado; pode ser inicial ou agudização de lesão crônica prévia (abscesso fênix).	Necrose pulpar evoluida (sequência clássica)	Drenagem + antibiótico/AINE se sistêmico

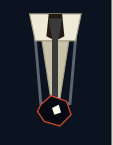
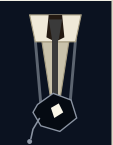
ALTERAÇÕES PERIAPICAIS CRÔNICAS

Esquema	Doença	Aparência clínica / achado-chave	Como diferenciar	Localização	Causa / etiologia	Tratamento
	Granuloma Periapical (Periodontite Apical Crônica)	Radiolusência apical bem definida, assintomática	Cisto radicular: a imagem radiográfica pode ser IDENTICA (a distinção definitiva e HISTOPATOLÓGICA - revestimento epitelial no cisto). Lesões maiores tendem a ser cisto.	Ápice radicular de dente não vital.	Necrose pulpar + inflamação crônica	Endodontia (ou exo) + curetagem se preciso
	Cisto Radicular (Periapical)	Radiolusência apical bem definida, pode ser grande	Granuloma periapical: imagem radiográfica pode ser indistinguível - a confirmação e HISTOPATOLÓGICA (revestimento epitelial completo = cisto).	Ápice de dente não vital; origem no epitélio residual de Malassez, epitélio sinusal ou revestimento de trajeto fistuloso.	Proliferação epitelial (restos de Malassez)	Endodontia/exodontia +/- cirurgia
	Cisto Radicular Lateral	Radiolusência na lateral da raiz	Cisto periodontal lateral (origem NÃO inflamatória, dente vital): o cisto radicular lateral esta sempre ligado a um dente com necrose pulpar/canal lateral infectado.	Face lateral da raiz de dente não vital.	Canal lateral infectado	Endodontia ou exodontia
	Cisto Residual	Radiolusência em área sem dente (pos-exodontia)	So ocorre em área SEM dente. A história de exodontia prévia no local sugere fortemente cisto residual (descartar outras lesões de área edêntula).	Processo alveolar EDÊNTULO (sem dente associado).	Curetagem incompleta após extração	Enucleação cirúrgica
	Abscesso Periapical Crônico	Radiolusência mal definida, silenciosa, +/- fístula	Granuloma/cisto: contorno BEM definido e sem fístula. Abscesso crônico: contorno MAL definido e comumente COM fístula ativa.	Ápice de dente não vital; frequentemente associado a trajeto fistuloso (drenagem crônica).	Infecção periapical de baixa virulência	Endodontia/exodontia + rastrear fístula

COMPLICAÇÕES POR DISSEMINAÇÃO

Esquema	Doença	Aparência clínica / achado-chave	Como diferenciar	Localização	Causa / etiologia	Tratamento
	Celulite Facial	Edema facial difuso, sem limite definido	Abscesso periapical: coleção LOCALIZADA e passível de drenagem pontual. Celulite: disseminação DIFUSA pelos planos faciais, sem coleção bem localizada.	Tecidos moles da face/pescoco adjacentes ao dente causador (espaco bucal, submandibular, canino etc.), conforme a relação do ápice com as inserções musculares.	Abscesso não drenado + defesa comprometida	Drenagem do foco + antibiótico sistêmico
	Trombose do Seio Cavernoso	Edema periorbitário bilateral, olho fixo/protruso	Celulite facial simples: edema unilateral, SEM protrusão/fixação do globo ocular e sem sinais de SNC. A trombose de seio cavernoso e bilateral e com sinais oculares/neurológicos graves.	Seio cavernoso (seio dural entre as camadas da dura-máter), atingido por disseminação retrógrada a partir da face.	Disseminação retrógrada via veia facial/oftálmica	Emergência: drenagem + ATB em alta dose
	Angina de Ludwig	Tumefação bilateral do assoalho, língua elevada	Celulite facial comum: não compromete via aérea. Angina de Ludwig: risco de vida IMEDIATO por obstrução de via aérea - sempre tratar como emergência.	Espaços sublingual, submandibular e submentoniano bilateralmente; pode progredir para espaco faríngeo lateral, retrofaríngeo e mediastino.	Infecção de molar inferior abaixo do milo-hioideo	Emergência: via aérea + drenagem + ATB

OSTEOMIELITES E CONDIÇÕES ÓSSEAS CORRELATAS

Esquema	Doença	Aparência clínica / achado-chave	Como diferenciar	Localização	Causa / etiologia	Tratamento
	Osteomielite Supurativa Aguda	Febre + leucocitose, evolução < 1 mês	Osteomielite CRÔNICA: sintomas agudos ha MENOS de 1 mês (aguda) x mais de 1 mês, mais branda e com fístula (crônica).	Espaços medulares do osso maxilar/mandibular, a partir de um foco odontogênico.	Infecção odontogênica + fator predisponente	Antibiótico + drenagem + tratar a causa
	Osteomielite Supurativa Crônica	Fístula + sequestro ósseo, evolução > 1 mês	Osteíte condensante: forma osso DENSO (radiopaco) reacional sem destruição/sequestro; a osteomielite crônica DESTROI o osso (radiolúcida, com sequestro).	Espaços medulares e corticais do osso mandibular (mais comum); predominância em homens (75%).	Infecção odontogênica persistente (cápsula fibrosa)	Cirurgia obrigatória + ATB IV em alta dose
	Osteíte Condensante	Radiopacidade uniforme no ápice, indolor	Osteomielite com periostite proliferativa (Garré): forma camadas paralelas ('casca de cebola') EXPANDINDO a superfície óssea; a osteíte condensante NÃO expande o osso e fica confinada ao redor do ápice.	Mais frequente na região de pre-molares e molares INFERIORES, em crianças e adultos jovens.	Estímulo inflamatório crônico de baixa intensidade	Tratar o dente causador (endo/exo)
	Osteomielite com Periostite Proliferativa (Garré)	Camadas radiopacas paralelas ('casca de cebola')	Osteíte condensante: radiopacidade compacta e confinada ao ápice, SEM expansão nem laminação. Garré tem expansão em camadas paralelas na cortical.	Mais comum em pre-molares e molares inferiores; localização preferencial na margem inferior da mandíbula, podendo acometer a cortical vestibular.	Cárie/infecção odontogênica em jovem	Eliminar o foco; remodela em 6-12 meses
	Osteíte Alveolar (Alvéolo Seco)	Alvéolo vazio, osso exposto, odor fétido	Osteomielite: a osteíte alveolar fica restrita ao alvéolo pos-extração (sem destruição óssea profunda/sequestro), enquanto a osteomielite envolve infecção óssea verdadeira com possível sequestro.	Mais frequente na região POSTERIOR da mandíbula, principalmente após extração de terceiros molares inferiores (20-25% dessas extrações).	Perda do coágulo pos-exodontia (tabagismo, trauma)	Irrigação + curativo sedativo (NÃO curetar)

BANCO DE QUESTÕES — CASOS CLÍNICOS (para autoavaliação)

Paciente de 23 anos sente dor aguda no dente 34 ao tomar refrigerante gelado, sem edema facial e sem febre. A dor cessa imediatamente após ela parar de beber. Qual o diagnóstico mais provável?

(a) Pulpite Reversível (b) Pulpite Irreversível (c) Necrose Pulpar (d) Periodontite Apical Aguda (Pericementite)

Mesmo paciente do caso anterior, mas agora a dor NÃO cessa ao parar de beber e continua latejando por horas, piorando quando ela deita. Qual a nova hipótese?

(a) Osteíte Alveolar (Alvéolo Seco) (b) Pulpite Irreversível (c) Pulpite Reversível (d) Granuloma Periapical (Periodontite Apical Crônica)

Criança de 12 anos tem dor difusa e intensa na região superior esquerda, espontânea, que piora com quente e alivia com frio; ha extensa destruição coronal no dente 26, sem edema facial ou febre. Qual a hipótese mais provável?

(a) Pulpite Irreversível (b) Pulpite Reversível (c) Periodontite Apical Aguda (Pericementite) (d) Abscesso Periapical Agudo

No caso anterior, por que o paciente NÃO consegue apontar exatamente qual dente doi?

(a) Porque o nervo alveolar inferior foi anestesiado (b) Porque nos estágios avançados da pulpite irreversível a dor se torna difusa (fibras nervosas pulpares não localizam bem o estímulo) (c) Porque o paciente tem neuralgia do trigêmeo (d) Porque ha uma fratura radicular associada

Mulher de 38 anos, diabética tipo I não controlada, tem dor pulsátil intensa no dente 37 ha 1 dia, não consegue comer nem dormir, com edema facial cervical iniciado ha 3h, febre de 37.8C e sem alteração radiográfica. Qual a hipótese mais provável?

(a) Trombose do Seio Cavernoso (b) Angina de Ludwig (c) Granuloma Periapical (Periodontite Apical Crônica) (d) Abscesso Periapical Agudo com celulite facial

No caso da paciente diabética, qual conduta inicial esta CORRETA?

(a) Encaminhar direto para cirurgia de drenagem do seio cavernoso (b) Apenas prescrever analgésico e aguardar redução espontânea do edema (c) Extrair o dente imediatamente sem qualquer medicação (d) Abrir o dente endodonticamente, prescrever antibiótico e analgésico, e reavaliar diariamente

Radiografia de rotina mostra uma imagem radiolúcida arredondada e BEM delimitada de 1 cm no ápice de um pre-molar inferior desvitalizado, em paciente assintomático. Qual exame CONFIRMA o diagnóstico definitivo (granuloma x cisto)?

(a) Exame histopatológico do tecido removido (b) Nova radiografia periapical (c) Teste de vitalidade pulpar (d) Tomografia computadorizada

Paciente com fístula intraoral persistente próxima ao ápice de um dente com necrose pulpar, sem dor, e radiografia mostrando radiolusência com limites MAL definidos. Qual o diagnóstico mais provável?

(a) Osteomielite Supurativa Crônica (b) Granuloma Periapical (Periodontite Apical Crônica) (c) Abscesso Periapical Crônico (d) Cisto Radicular (Periapical)

Tres dias após a exodontia de um terceiro molar inferior, um paciente fumante relata dor forte irradiando para o ouvido, com odor fétido e alvéolo vazio (sem coágulo) e muito sensível a sondagem. Qual o diagnóstico?

(a) Pericoronarite (b) Osteíte Alveolar (Alvéolo Seco) (c) Abscesso Periapical Agudo (d) Osteomielite Supurativa Aguda

No caso do alvéolo seco, qual conduta esta CORRETA?

(a) Realizar nova extração do dente adjacente (b) Curetar bem o alvéolo para remover todo o tecido residual (c) Irrigar com solução salina e usar curativo sedativo, sem curetar o alvéolo (d) Prescrever apenas antibiótico sistêmico, sem qualquer manejo local

Adolescente de 13 anos apresenta aumento de volume assimetrico e indolor na mandíbula; a tomografia mostra camadas ósseas radiopacas paralelas ('casca de cebola') associadas a um molar cariado. Qual o diagnóstico?

(a) Osteíte Condensante (b) Cisto Residual (c) Osteomielite com Periostite Proliferativa (Garré) (d) Osteomielite Supurativa Crônica

Achado radiográfico casual em jovem assintomático: área radiopaca BEM definida e uniforme, SEM expansão óssea, junto ao ápice de um pre-molar inferior com cárie profunda. Qual o diagnóstico?

(a) Granuloma Periapical (Periodontite Apical Crônica) (b) Osteíte Condensante (c) Osteomielite com Periostite Proliferativa (Garré) (d) Osteomielite Supurativa Crônica

Paciente com infecção odontogênica evoluindo ha 2 meses, fístula cutanea, fragmentos ósseos radiopacos soltos (sequestros) na radiografia e dor moderada. Qual o diagnóstico?

(a) Osteomielite Supurativa Crônica (b) Osteomielite Supurativa Aguda (c) Osteíte Condensante (d) Osteíte Alveolar (Alvéolo Seco)

Paciente evolui após abscesso dentário não tratado com edema periorbitário BILATERAL, protrusão e FIXAÇÃO do globo ocular, febre alta e cefaleia. Qual o diagnóstico e a conduta?

(a) Celulite Facial - antibiótico oral ambulatorial (b) Angina de Ludwig - manutenção de via aérea prioritária (c) Trombose do Seio Cavernoso - emergência hospitalar com drenagem cirúrgica e antibiótico em altas doses (d) Osteomielite Supurativa Aguda - antibiótico e drenagem odontológica

Paciente com infecção de molar inferior evolui com tumefação bilateral do assoalho da boca, língua elevada, dificuldade para respirar e necessidade de ficar sentado ereto. Qual o diagnóstico e a prioridade de tratamento?

(a) Celulite Facial - antibiótico oral e observação (b) Angina de Ludwig - manter via aérea e depois drenar/tratar o foco (c) Abscesso Periapical Crônico - endodontia eletiva (d) Trombose do Seio Cavernoso - avaliação oftalmológica

GABARITO

01: (a) 02: (b) 03: (a) 04: (b) 05: (d) 06: (d) 07: (a) 08: (c) 09: (b) 10: (c) 11: (c) 12: (b) 13: (a) 14: (c) 15: (b)